EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 82002
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-05 12:33:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DOMINGO ANTONIO MENDEZ MENDEZ			RUN	: 7.928.523-4
F.Nac	: 16-02-1956	Edad	: 68 AÑOS, 1 MES	Género	: Masculino
Dirección	: TIUQUILEMU			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 86968385		
Fecha Ingreso	: 2024-03-30	Fecha Egreso	: 2024-04-05 12:33:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

ITU por -E. coli BLEE
THE: Hipokalemia, hiponatremia en resolución
Sx Convulsivo secundario a Encefalopatía metabólica (hiponatremia + hipoxemia)
UPP sacra, trocantérea Izq, glútea D°

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39-OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente hospitalizado en contexto de mayor compromiso CEG, asociado a infección urinaria además de aumento de secreciones bronquiales. Desde ingreso sin requerimientos de oxígeno. Se rescata UCT que reporta E coli. BLEE sensible a carbapenémicos, sin embargo, desde ingreso únicamente con uso de ceftriaxona+metronidazol con buena respuesta clínica. Se decide mantener terapia ATB hasta el cumplimiento de 7 días con descenso franco de parámetros inflamatorios además de ausencia de compromiso respiratorio o algún otro signo o síntoma asociado.
Durante estancia en servicio se evidencia UPP sacra con signos de infección local, sin compromiso generalizado. Se solicita cultivo de herida. Se deriva HODOM para eventual terapia vSNG según resultado de cultivo (no disponible para momento de egreso, disponible mañana, según Bacteriología. Aparentemente Pseudomona MS).
En vista de tiempo prolongado con uso de SNG además de compromiso determinante de incapacidad de alimentación VO, se decide GTT. Se deriva caso a Endoscopia. Dra. Acero en conocimiento de caso, hará contacto con familiares posterior a egreso hospitalario. En consciencia de derivación HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. Derivo HODOM
2. Reposo semisentado 30° | PUPP
3. Regimen papilla por SNG
4. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
5. Salbutamol 2 puff c/4hrs por AC
6. Omeprazol 20 mg al dia vSNG

7. Levodopa/carbidopa 250/25, 1/4 comp 8:00-10:30-13:00-15:30-18:00-20:30 vSNG
8. Pramipexol 1/2 comp 8:00-13:00-18:00 vSNG
9. Sertralina 50 mg al dia vSNG
10. Rescatar cultivo herida
11. Pendiente valoración por endoscopia para GTT
12. EOC + UCT en 7 días por APS
13. Control SOS

andres david velasquez guerra MEDICO TRATANTE 27124399-5	JEFE SERVICIO